外傷性気胸を伴う心筋梗塞が検査技師の迅速なフィードバックにより診断に至った症例

◎坂本 悠斗[1)]、石神 弘子[1)]、織田 典子[1)]、枝光 泰聖[1)]、岩田 英紘[1)]、近藤 規明[1)]、杉野 裕志[1)]
日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院[1)]

【はじめに】
気胸では特徴的な心電図変化を呈するが虚血性変化を伴った場合、その心電図判読は容易ではない。今回、外傷性気胸を伴う患者において臨床検査技師からの迅速なフィードバックを契機に診断に至った症例を経験したため報告する。
【症例】
60歳代男性。バイク運転中の単独転倒により左肩を強打。他院で外傷性気胸、肋骨骨折および左鎖骨骨折と診断され、胸部外傷管理目的に当院へ紹介受診となった。救急外来で全身評価および検査を行ったところ、状態は安定しており、一時帰宅となった。翌日の外来受診時の心電図検査でR波増高不良、II、III、aVf、V3-6のST上昇を認め、臨床検査技師よりパニック値として速やかに主治医へ報告するとともに心エコー検査の追加を提案した。骨折に伴う肩を中心とした痛みはあるが胸痛の自覚はなかった。前日の救急外来で記録された心電図とは著変なかった。血液検査でCK上昇を認めていたが心筋マーカーは未測定であった。パニック値報告後に追加検査が実施され、トロポニンTは0.760ng/mLと高値、心エコー検査で心尖部壁運動低下および心基部過収縮を認めた。たこつぼ型心筋症が疑われたが急性冠症候群も否定できず精査を行った。冠動脈造影でLAD遠位部に責任病変を確認し急性心筋梗塞と診断され、経皮的冠動脈インターベンションにより血行再建を得た。
【考察】
本症例では、気胸を伴う胸部外傷手術前に心電図検査を実施していたが、外傷による疼痛は認められたものの、冠疾患を疑うような胸痛が認めなかったことから、初期評価では循環器疾患の可能性が十分に考慮されず、急性心筋梗塞の診断に至らなかった。翌日の再評価の際、臨床検査技師からの迅速なフィードバックにより追加検査が実施され、診断・治療に繋がったと考えられる。
【結語】
本症例は気胸を伴う外傷患者においても循環器疾患を鑑別に含める重要性を示すとともに、臨床検査技師による異常所見の検出と迅速なフィードバックが診断の転機となり得ることを示唆した。連絡先：052-832-1121（内線 73606）